ONEMA-POP-032 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

ONEMA-POP-032 — Educação e Monitoramento na Doença Renal
Crônica em Tratamento Conservador

1. Identificação institucional

983558 | Data: 09/11/2026.

2. Objetivo e abrangência

Padronizar educação e monitoramento na doença renal crônica em tratamento conservador na atuação da rede ONEMA ONE, com avaliação, execução segura, continuidade e escalonamento. Aplicável ao atendimento domiciliar e, quando pertinente, digital; não substitui decisões médicas nem suporte de emergência.

3. Competência, indicações e contraindicações

Execução e julgamento clínico por enfermeiro habilitado, conforme competências e treinamento. Indicações: Pessoas com
DRC em tratamento conservador, sem indicação de intervenção aguda no domicílio. Contraindicações operacionais: ausência de consentimento ou de condições seguras, urgência incompatível com atendimento eletivo, ou ação fora da competência/prescrição.

4. Materiais, equipamentos e fornecimento

Enfermeiro: aparelhos para sinais vitais e avaliação de edema; paciente: exames disponíveis, prescrições, lista de medicamentos, registros de peso/diurese. Em visitas presenciais, o profissional dispõe de aparelho de pressão validado, estetoscópio, termômetro e oxímetro; utilizar conforme avaliação. Insumos específicos são providenciados pelo paciente/responsável, salvo acordo contratual.

5. Avaliação clínica e preparo

Estágio G/A conhecido, eTFG e albuminúria, PA, edema, diurese, náuseas, prurido, fadiga, sinais de hipercalemia, medicamentos e seguimento nefrológico. Confirmar identidade, consentimento, privacidade, ambiente e plano prévio; estabelecer linha de base e reconhecer urgências antes de iniciar.

6. Execução técnica numerada

1. Confirmar diagnóstico, estágio e resultados laboratoriais datados; não inferir estágio apenas por sintomas.

2. Revisar tendência de eTFG e relação albumina/creatinina urinária, registrando data, unidade e fonte.

3. Aferir PA e avaliar edema, dispneia, hidratação e alterações da diurese na visita.

4. Reconciliar medicamentos e identificar uso de anti-inflamatórios ou suplementos sem orientação, comunicando riscos à

equipe.

5. Verificar adesão a consultas, coleta de exames e orientações dietéticas individualizadas.

6. Investigar sinais de urgência: dispneia importante, anúria, arritmia/palpitações com fraqueza intensa, confusão ou

edema pulmonar.

7. Comunicar ao médico alterações relevantes de eTFG, albuminúria, potássio ou sintomas, sem prescrever correções.

8. Documentar educação, barreiras, plano de seguimento e confirmação de encaminhamento.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Anúria aguda, dispneia grave, arritmia suspeita, alteração de consciência: emergência. Não orientar aumento

indiscriminado de líquidos. Em emergência, acionar SAMU 192 e registrar horário e destinatário; não retardar atendimento

por registro digital.

8. Cuidados posteriores e orientações

Reforçar automedicação segura, controle pressórico, exames seriados e dieta individualizada por nutricionista/equipe.

Confirmar compreensão por retorno verbal e definir quem será contatado em caso de piora.

9. Registros obrigatórios na Carteira Digital ONEMA

Identificação, data/hora e modalidade, consentimento, queixa, histórico e avaliação, sinais vitais pertinentes, diagnósticos

e plano de Enfermagem, passos executados e não executados com justificativa, resposta clínica, intercorrências,

orientações, contatos e encaminhamentos, profissional responsável e assinatura/trilha de auditoria.

10. Referências técnicas específicas e rastreáveis

 KDIGO 2024 — CKD Guideline Executive Summary —

https://kdigo.org/wp-content/uploads/2017/02/KDIGO-2024-CKD-Guideline-Executive-Summary.pdf

 COFEN, Resolução nº 736/2024 — Processo de Enfermagem —

https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-736-de-17-de-janeiro-de-2024/